

## 1 皮膚障害の薬薬連携 ― 予防のスキンケアから

| 病院薬剤師                    | 病院と共有する情報              | 保険薬局薬剤師                   |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| ① 予防内服・保湿剤・外用薬の処方セットの提案  | 予防の処方セット<br>(保湿剤・予防内服) | ① 保湿剤の量・回数・塗り方を実演で説明      |
| ② 皮膚症状の評価と休薬・減量の判断支援     | 皮膚症状の程度<br>(部位ごと)      | ② 外用ステロイドの部位別の使い分けを確認     |
| ③ 抗EGFR抗体投与時の皮膚症状・Mg値の確認 | 外用薬の使用量<br>(残量・塗り方)    | ③ 保湿剤・外用薬の残量から使用状況を把握     |
| ④ 重症薬疹・ICIの皮膚障害への院内対応    | Mg値<br>(抗EGFR抗体)       | ④ 足の裏の痛み・歩行への支障を聴取(手足症候群) |
| ⑤ 皮膚科への紹介と外用ステロイドのランク調整  |                        | ⑤ 胃薬・サプリなど他院処方・市販薬の相互作用確認 |

## 2 予防と治療 ― 皮膚障害の型で使い分ける

|                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ざ瘡様皮疹(EGFR阻害薬)</b><br>予防(治療開始時から) 保湿・日焼け止め、テトラサイクリン系の予防内服<br>症状が出た時 部位に応じた強さの外用ステロイド<br>薬剤師の確認ポイント<br>予防内服の服用状況、ミノサイクリンのめまい・色素沈着 | <b>爪囲炎</b><br>予防(治療開始時から) 深爪を避け、爪の周りへの刺激を減らす<br>症状が出た時 外用ステロイド、テーピング、皮膚科での処置<br>薬剤師の確認ポイント<br>痛み・歩行への影響、皮膚科受診の要否 | <b>手足症候群</b><br>予防(治療開始時から) 保湿剤、圧迫・摩擦・熱を避ける、厚い角質の事前ケア<br>症状が出た時 強めの外用ステロイド、休薬・減量<br>薬剤師の確認ポイント<br>保湿の回数(1日2回以上)、靴・家事の工夫 |
| <b>皮膚乾燥・亀裂</b><br>予防(治療開始時から) 入浴後すぐの保湿<br>症状が出た時 亀裂にはワセリン等で保護<br>薬剤師の確認ポイント<br>亀裂・びらんには尿素製剤は刺激になるため見直し                              | <b>ICIの皮疹・かゆみ</b><br>予防(治療開始時から) 保湿<br>症状が出た時 外用ステロイド・抗ヒスタミン薬<br>薬剤師の確認ポイント<br>粘膜症状・水疱は重症薬疹を疑い即受診                |                                                                                                                         |

## 3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

| 重要度                       | 薬剤(機序)                       | 相手の薬(区分)                       | 起こること       | 薬局での対応                 |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | ゲフィチニブ・エルロチニブ<br>胃内pH上昇で吸収低下 | 処方薬 市販薬<br>PPI・H2ブロッカー         | 血中濃度↓→効果減弱  | 市販の胃薬も含めて確認            |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | エルロチニブ<br>CYP1A2誘導           | 生活習慣<br>喫煙                     | 血中濃度↓       | 喫煙状況を確認し禁煙を支援          |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | ミノサイクリン(皮疹の予防内服)<br>キレート形成   | 処方薬 市販薬 サプリ・食品<br>鉄剤・制酸剤・カルシウム | 吸収↓→予防効果の減弱 | 服用時間をずらすよう指導           |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>警告   | カベシタピン<br>ワルファリンの代謝を阻害       | 処方薬<br>ワルファリン                  | PT-INR↑→出血  | 他院処方を確認し、INRの測定を処方医と共有 |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | レゴラフェニブ・ソラフェニブ等<br>CYP3A4誘導  | サプリ・食品<br>セイヨウオトギリソウ           | 血中濃度↓→効果減弱  | サプリメントの使用を確認           |

## 4 服薬指導タイムライン(声かけ例)

| ① 治療開始前                                         | ② 開始～2週                                   | ③ 1～2か月                                 | ④ 随時                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| “皮膚の症状は、予防のスキンケアを早く始めるほど軽くすみます。今日から保湿を習慣にしましょう” | “顔や胸にニキビのような発疹が出て、自己判断で薬をやめず、塗り薬を使ってください” | “爪の周りの腫れや痛み、手足のひび割れはありませんか”             | “熱を伴う発疹や、目の充血・口のただれがあれば、すぐに連絡してください” |
| ✓薬局で確認<br>お薬手帳でレジメン、予防内服・保湿剤・外用薬の処方と量           | ✓薬局で確認<br>皮疹・手足の発赤の有無、外用ステロイドの部位別の使い分け    | ✓薬局で確認<br>爪囲炎・乾燥・亀裂、保湿剤・外用薬の残量から使用状況を把握 | ✓薬局で確認<br>新たに始めた薬(他院処方・市販薬)の有無       |
| △ここに注意<br>保湿剤の量と回数を実演で説明                        | △ここに注意<br>足の裏の痛みで歩きにくい時は連絡                | △ここに注意<br>亀裂への尿素製剤は刺激になるため見直し           | △ここに注意<br>粘膜症状・水疱は重症薬疹を疑い即受診         |